Correction de santé publique

Examen blanc du diplôme d’État
Licence 3 SIO Abengourou • Version D
Durée du sujet : 1 h 30

58 questions avec propositions, réponses, explications et sources.

Pour les questions à choix doubles : A = Vrai ; B = Faux. Les calculs suivent les conventions du cours et les données propres à chaque étude de cas.

Référence principale : SANTE PUBLIQUE L3.pdf, unité pédagogique de santé publique INFAS. Les citations indiquent la page imprimée ; le compteur PDF affiche une page de plus.

Questions à choix multiples

Question 1 — Le but principal du COGES est :

A. Sanctionner le personnel

B. Associer la communauté à la gestion du centre de santé

C. Construire des hôpitaux universitaires

D. Remplacer l'État

Réponse : B

Explication : Le COGES associe les représentants communautaires aux décisions concernant la gestion et le fonctionnement du centre. Il ne remplace pas l’État.

Source : SANTE PUBLIQUE L3.pdf, p. imprimée(s) 37–38 (compteur PDF : une page de plus), but de la création du COGES.

Question 2 — Le niveau central de gestion des données sanitaires est représenté par :

A. l'EPHR

B. Le District sanitaire

C. La DIIS

D. L'ESPC

Réponse : C

Explication : La DIIS, Direction de l’Informatique et de l’Information sanitaire, représente le niveau central de gestion des données dans le référentiel du cours. Le district est périphérique.

Source : SANTE PUBLIQUE L3.pdf, p. imprimée(s) 52 (compteur PDF : une page de plus), niveau central du système d’information sanitaire.

Question 3 — Une catastrophe est :

A. Une urgence mineure

B. Un événement sans impact

C. Un événement dépassant la capacité de réaction de la communauté

D. Une simple vulnérabilité

Réponse : C

Explication : La catastrophe produit des effets négatifs importants qui dépassent les capacités de réaction de la collectivité affectée.

Source : SANTE PUBLIQUE L3.pdf, p. imprimée(s) 59 (compteur PDF : une page de plus), définition de la catastrophe.

Question 4 — Le style de supervision adapté aux situations d'urgence est :

A. Démocratique

B. Participatif

C. Autocratique

D. Laissez-faire

Réponse : C

Explication : Le style autocratique permet de donner des instructions spécifiques et de décider sans délai. Le cours le réserve notamment aux situations d’urgence et de blocage.

Source : SANTE PUBLIQUE L3.pdf, p. imprimée(s) 64 (compteur PDF : une page de plus), styles de supervision.

Question 5 — La méthode directe de supervision repose sur :

A. L'analyse documentaire uniquement

B. L'observation directe du personnel au travail

C. Le questionnaire administratif

D. Le rapport annuel

Réponse : B

Explication : La méthode directe consiste à observer l’agent pendant l’exécution de sa tâche. Une intervention immédiate est nécessaire si le geste met le patient en danger.

Source : SANTE PUBLIQUE L3.pdf, p. imprimée(s) 66 (compteur PDF : une page de plus), méthode directe de supervision.

Question 6 — Parmi les outils du superviseur figure :

A. La fiche d'observation

B. Le carnet de vaccination

C. Le registre de consultation

D. La carte sanitaire nationale

Réponse : A

Explication : La fiche d’observation ou de supervision guide l’observation des tâches et la comparaison avec les normes.

Source : SANTE PUBLIQUE L3.pdf, p. imprimée(s) 68 (compteur PDF : une page de plus), outils du superviseur.

Question 7 — La durée du mandat des membres du COGES est de :

A. 1 an

B. 2 ans

C. 3 ans renouvelables

D. 5 ans

Réponse : C

Explication : Le cours indique un mandat de trois ans, renouvelable, pour les membres du COGES sanitaire.

Source : SANTE PUBLIQUE L3.pdf, p. imprimée(s) 38 (compteur PDF : une page de plus), durée du mandat des membres du COGES.

Question 8 — Le bureau du COGES comprend :

A. Président, secrétaire, trésorier, un commissaire au compte

B. Président, responsable financier, responsable administratif et technique

C. Président, maire, préfet

D. Président et deux infirmiers

Réponse : B

Explication : Le bureau comprend un président communautaire, un responsable communautaire de la gestion financière et un responsable de la gestion administrative et technique issu du personnel de santé.

Source : SANTE PUBLIQUE L3.pdf, p. imprimée(s) 38 (compteur PDF : une page de plus), composition du bureau du COGES.

Question 9 — Le responsable de la gestion financière est chargé :

A. Des consultations médicales

B. De l'enregistrement des recettes

C. De la vaccination

D. De la surveillance épidémiologique

Réponse : B

Explication : Le responsable financier recueille les fonds, enregistre les recettes dans le livret de caisse, effectue les versements bancaires et participe au bilan financier.

Source : SANTE PUBLIQUE L3.pdf, p. imprimée(s) 41 (compteur PDF : une page de plus), fonctions du responsable financier.

Question 10 — Un indicateur est :

A. Une donnée brute

B. Une opinion

C. Une variable permettant de mesurer un aspect d'une intervention

D. Un rapport annuel

Réponse : C

Explication : Un indicateur est une variable quantitative ou qualitative permettant de mesurer un aspect d’une intervention, d’un programme ou d’un projet.

Source : SANTE PUBLIQUE L3.pdf, p. imprimée(s) 44 (compteur PDF : une page de plus), définition d’un indicateur.

Question 11 — L'information sanitaire est :

A. Une donnée non traitée

B. Une donnée contextualisée et utile

C. Un registre

D. Une fiche de consultation

Réponse : B

Explication : L’information résulte de la transformation des données brutes en éléments significatifs, contextualisés et utiles pour les décisions.

Source : SANTE PUBLIQUE L3.pdf, p. imprimée(s) 45 (compteur PDF : une page de plus), donnée et information.

Question 12 — La première étape du processus de génération de l'information sanitaire est :

A. L'analyse

B. L'interprétation

C. La collecte

D. La diffusion

Réponse : C

Explication : Parmi les opérations proposées, la collecte précède la compilation, le traitement, l'analyse, l'interprétation et la diffusion. Les besoins en information sont définis en amont.

Source : SANTE PUBLIQUE L3.pdf, p. imprimée(s) 47 (compteur PDF : une page de plus), processus de génération de l'information sanitaire.

Question 13 — Le taux de promptitude est calculé à partir :

A. Des consultations

B. Des rapports reçus dans le délai requis

C. Des supervisions

D. Des naissances

Réponse : B

Explication : Taux de promptitude = nombre de rapports reçus dans le délai requis ÷ nombre de rapports attendus × 100. Le dénominateur est l'ensemble des rapports attendus.

Source : SANTE PUBLIQUE L3.pdf, p. imprimée(s) 47–48 (compteur PDF : une page de plus), promptitude des rapports.

Question 14 — La rétro-information est :

A. Une transmission ascendante

B. Une sanction administrative

C. Un retour des informations vers les producteurs des données

D. Une analyse statistique

Réponse : C

Explication : La rétro-information restitue l'information produite aux structures et acteurs qui ont fourni les données ; elle soutient l'amélioration des activités.

Source : SANTE PUBLIQUE L3.pdf, p. imprimée(s) 47 (compteur PDF : une page de plus), rétro-information.

Question 15 — Selon l'OMS, le SIS sert à :

A. Construire des centres de santé

B. Fournir des renseignements sanitaires pour la prise de décision

C. Recruter du personnel

D. Payer les agents

Réponse : B

Explication : Le SIS fournit les renseignements nécessaires à la surveillance de la santé et à l'amélioration des décisions et de la gestion à tous les niveaux.

Source : SANTE PUBLIQUE L3.pdf, p. imprimée(s) 45 (compteur PDF : une page de plus), définition du système d'information sanitaire attribuée à l'OMS.

Question 16 — Le style démocratique de supervision :

A. Empêche toute initiative

B. Repose sur la participation des collaborateurs

C. Est réservé aux urgences

D. Exclut le dialogue

Réponse : B

Explication : Le superviseur démocratique ou participatif associe ses collaborateurs à la planification et aux décisions, et encourage leurs initiatives.

Source : SANTE PUBLIQUE L3.pdf, p. imprimée(s) 64 (compteur PDF : une page de plus), supervision démocratique ou participative.

Étude de cas 1

L'équipe du Centre de Santé Rural de Gnimpleu réalise le monitorage des consultation curatives (CSC) sur un semestre. La population totale annuelle est de 8 000 habitants, dont 6 400 résidents dans le rayon de 10 km. Au cours du semestre, 2 400 personnes distinctes ont eu au moins un contact curatif avec l'ESPC ; parmi ces consultants, 1 800 ont reçu un traitement et payé le prix correct ; parmi ces 1 800, 1 500 ont en outre été traités selon les directives nationales avec des médicaments bien conservés et non périmés. Un dossier individuel révèle un traitement facturé correctement mais délivré avec un médicament périmé.

À la veille du monitorage, le solde bancaire est de 1 000 000 F CFA, dont 600 000 F CFA correspondent à des recettes du semestre monitoré déjà déposées ; le solde intègre les intérêts et agios pertinents. Les RVME justifiées par reçus sont de 400 000 F CFA et les RCAS de 600 000 F CFA. Les DO retenues dans le plan d'affectation sont de 700 000 F CFA. Les montants bancaires et les recettes sont fournis selon les conventions du support, sans supposer que la SAB et le FR représentent une même masse financière.

Question 17 — L'accessibilité géographique (AG) est :

A. 60 %.

B. 10 %.

C. 80 %.

D. 100 %.

Réponse : C — 80 %

Explication : AG = population résidant dans le rayon de 10 km ÷ population totale × 100 = 6 400 ÷ 8 000 × 100 = 80 %. Le prorata semestriel des deux populations donnerait le même pourcentage.

Source : SANTE PUBLIQUE L3.pdf, p. imprimée(s) 9 (compteur PDF : une page de plus), accessibilité géographique des consultations de soins curatifs ; données du cas 1.

Question 18 — La population cible semestrielle est :

A. 4 000 personnes.

B. 6 400 personnes.

C. 2 400 personnes.

D. 1 800 personnes.

Réponse : A — 4 000 personnes

Explication : Pour le monitorage semestriel des consultations curatives, la convention du cours est : population cible = population totale annuelle ÷ 2. Calcul : 8 000 ÷ 2 = 4 000. Il s’agit d’une cible conventionnelle d’activité, et non d’une division réelle du nombre d’habitants.

Source : SANTE PUBLIQUE L3.pdf, p. imprimée(s) 7 (compteur PDF : une page de plus), population cible du monitorage ; données du cas 1.

Question 19 — Quel est le taux d'utilisation des services (US) ?

A. 70 %.

B. 100 %.

C. 60 %.

D. 80 %.

Réponse : C — 60 %

Explication : US = consultants distincts ayant eu au moins un contact curatif pendant le semestre ÷ population cible semestrielle × 100 = 2 400 ÷ 4 000 × 100 = 60 %. Ne pas compter plusieurs fois une même personne.

Source : SANTE PUBLIQUE L3.pdf, p. imprimée(s) 9 (compteur PDF : une page de plus), utilisation des services ; données du cas 1.

Question 20 — La couverture adéquate (CA) est :

A. 45 %.

B. 85 %.

C. 65 %.

D. 90 %.

Réponse : A — 45 %

Explication : CA = personnes ayant reçu un traitement et payé le prix correct ÷ population cible semestrielle × 100 = 1 800 ÷ 4 000 × 100 = 45 %. Dans la cascade de couverture, le dénominateur reste la population cible ; 1 800 ÷ 2 400 mesurerait une proportion conditionnelle différente.

Source : SANTE PUBLIQUE L3.pdf, p. imprimée(s) 9–10 (compteur PDF : une page de plus), couverture adéquate des soins curatifs ; données du cas 1.

Question 21 — La couverture effective (CE) est :

A. 37,5 %

B. 3,7 %

C. 5,3 %

D. 73 %

Réponse : A — 37,5 %

Explication : CE = personnes traitées selon les directives nationales avec des médicaments bien conservés et non périmés ÷ population cible semestrielle × 100 = 1 500 ÷ 4 000 × 100 = 37,5 %. Le dossier avec médicament périmé peut satisfaire le prix correct, mais ne remplit pas le critère de qualité de la couverture effective.

Source : SANTE PUBLIQUE L3.pdf, p. imprimée(s) 10 (compteur PDF : une page de plus), couverture effective ; données du cas 1.

Question 22 — Quel montant correspond au fonds de réserve (FR) ?

A. 100 000 F CFA.

B. 4 000 000 F CFA.

C. 400 000 F CFA.

D. 1 400 000 F CFA.

Réponse : C — 400 000 F CFA

Explication : FR = solde bancaire à la veille du monitorage − recettes du semestre déjà déposées = 1 000 000 − 600 000 = 400 000 F CFA. Les intérêts et agios sont déjà intégrés au solde : ne pas les appliquer une seconde fois.

Source : SANTE PUBLIQUE L3.pdf, p. imprimée(s) 17–18 (compteur PDF : une page de plus), fonds de réserve ; données du cas 1.

Question 23 — Quel montant correspond à la SAB ?

A. 1 000 000 F CFA

B. 400 000 F CFA.

C. 80 000 F CFA

D. 8 000 000 F CFA

Réponse : A — 1 000 000 F CFA

Explication : SAB = RVME justifiées + RCAS = 400 000 + 600 000 = 1 000 000 F CFA. Les 600 000 F déjà déposés sont utilisés pour isoler le fonds de réserve ; ils ne sont pas à ajouter une seconde fois à la SAB. La SAB et le FR représentent ici deux rubriques distinctes.

Source : SANTE PUBLIQUE L3.pdf, p. imprimée(s) 18 (compteur PDF : une page de plus), somme à budgétiser ; données du cas 1.

Question 24 — Quel montant correspond aux dépenses de fonctionnement local ?

A. 100 000 F CFA.

B. 400 000 F CFA.

C. 600 000 F CFA.

D. 300 000 F CFA.

Réponse : D — 300 000 F CFA

Explication : DFL = SAB − DO = 1 000 000 − 700 000 = 300 000 F CFA.

Source : SANTE PUBLIQUE L3.pdf, p. imprimée(s) 19 (compteur PDF : une page de plus), dépenses de fonctionnement local ; données du cas 1.

Question 25 — Quel est le plafond des frais de réparation de l’immeuble ?

A. 40 000 F CFA.

B. 60 000 F CFA.

C. 30 000 F CFA.

D. 10 000 F CFA.

Réponse : C — 30 000 F CFA

Explication : Le plafond de réparation de l’immeuble est de 10 % des DFL : 300 000 × 10 % = 30 000 F CFA. Ne pas utiliser les dépenses obligatoires comme base de calcul.

Source : SANTE PUBLIQUE L3.pdf, p. imprimée(s) 19 (compteur PDF : une page de plus), plafond de la rubrique immeuble.

Question 26 — Quel est le plafond des imprévus ?

A. 15 000 F CFA.

B. 150 000 F CFA.

C. 30 000 F CFA.

D. 10 000 F CFA.

Réponse : A — 15 000 F CFA

Explication : Le plafond des imprévus est de 5 % des DFL : 300 000 × 5 % = 15 000 F CFA.

Source : SANTE PUBLIQUE L3.pdf, p. imprimée(s) 19 (compteur PDF : une page de plus), plafond de la rubrique imprévus.

Étude de cas 2

Dans le Centre de Santé de Zranwopleu, Monsieur KONAN, l'infirmier Chef de poste a fait sortir 200 doses de Penta durant le mois et 180 doses ont été administrées. Pour le mois suivant, le besoin théorique (BT) est de 400 doses ; le stock de sécurité pour les vaccins est de 25 % du BT et le stock utilisable déjà disponible est de 120 doses. Toutes les quantités sont exprimées en doses.

Question 27 — Quel est le taux d'utilisation du mois écoulé ?

A. 10 %

B. 20 %

C. 80 %

D. 90 %

Réponse : D — 90 %

Explication : Taux d'utilisation = doses administrées ÷ doses sorties × 100 = 180 ÷ 200 × 100 = 90 %.

Source : Formules de Santé Publique actualisées rédigées par IDE GBOKO ANGE AXEL.pdf, p. 6–7, besoins, stocks, taux et facteur de perte ; données du cas 2.

Question 28 — Quel est le taux de perte correspondant ?

A. 5 %.

B. 10 %.

C. 20 %.

D. 90 %.

Réponse : B — 10 %

Explication : Doses perdues = 200 − 180 = 20. Taux de perte = 20 ÷ 200 × 100 = 10 %, soit 100 % − 90 %.

Source : Formules de Santé Publique actualisées rédigées par IDE GBOKO ANGE AXEL.pdf, p. 6–7, besoins, stocks, taux et facteur de perte ; données du cas 2.

Question 29 — Quel facteur de perte découle de ce taux ?

A. 0,90.

B. 1,00.

C. Environ 1,11.

D. 2,00.

Réponse : C — Environ 1,11

Explication : Facteur de perte = 100 ÷ (100 − taux de perte en %) = 100 ÷ 90 = 1,111… Il est sans unité ; le taux doit être exprimé de manière cohérente dans la formule.

Source : Formules de Santé Publique actualisées rédigées par IDE GBOKO ANGE AXEL.pdf, p. 6–7, besoins, stocks, taux et facteur de perte ; données du cas 2.

Question 30 — Quel est le besoin réel pour le mois suivant ?

A. 280 doses.

B. 400 doses.

C. 500 doses.

D. 520 doses.

Réponse : C — 500 doses

Explication : Stock de sécurité = 25 % du BT = 0,25 × 400 = 100 doses. Besoin réel selon la convention du cas = BT + stock de sécurité = 400 + 100 = 500 doses. Le BT est donné : ne pas lui appliquer une nouvelle fois le facteur de perte.

Source : Formules de Santé Publique actualisées rédigées par IDE GBOKO ANGE AXEL.pdf, p. 6–7, besoins, stocks, taux et facteur de perte ; données du cas 2.

Question 31 — Quelle quantité de doses faut-il commander, sous réserve du conditionnement en flacons ?

A. 120.

B. 280.

C. 380.

D. 500.

Réponse : C — 380 doses

Explication : Quantité à commander = besoin réel − stock utilisable disponible = 500 − 120 = 380 doses. Adapter ensuite au nombre entier de flacons et à leur présentation, qui ne sont pas précisés.

Source : Formules de Santé Publique actualisées rédigées par IDE GBOKO ANGE AXEL.pdf, p. 6–7, besoins, stocks, taux et facteur de perte ; données du cas 2.

Questions à choix doubles

Question 32 — Les données sont déjà des informations interprétées.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Les données sont des nombres, mesures ou textes bruts. L’information est issue de leur traitement et de leur mise en contexte. Reformulation : les données ne sont pas encore des informations interprétées.

Source : SANTE PUBLIQUE L3.pdf, p. imprimée(s) 44–45 (compteur PDF : une page de plus), définitions de donnée et d’information.

Question 33 — L'information sanitaire est le résultat du traitement et de l'analyse des données.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Le traitement et l’analyse transforment les données en information utile ; l’interprétation leur donne du sens pour l’action.

Source : SANTE PUBLIQUE L3.pdf, p. imprimée(s) 45 (compteur PDF : une page de plus), information, traitement et analyse.

Question 34 — La collecte des données sanitaires consiste à enregistrer les données dans les registres et rapports.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La collecte comprend l'enregistrement dans les registres d'activités, puis le report ou la compilation dans les fiches de rapport.

Source : SANTE PUBLIQUE L3.pdf, p. imprimée(s) 47 (compteur PDF : une page de plus), collecte des données sanitaires.

Question 35 — Le rapport mensuel des ESPC doit être transmis au district sanitaire au plus tard le 5 du mois suivant.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai selon le calendrier du cours

Explication : Le rapport mensuel d'activités de l'ESPC doit parvenir au CSE du district au plus tard le 5 du mois suivant, selon le référentiel enseigné.

Source : SANTE PUBLIQUE L3.pdf, p. imprimée(s) 47–48 (compteur PDF : une page de plus), transmission des rapports des ESPC.

Question 36 — Le taux de complétude mesure la proportion de rapports reçus parmi ceux attendus.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Complétude = rapports reçus ÷ rapports attendus × 100. Elle se distingue de la promptitude, qui exige en plus le respect du délai.

Source : SANTE PUBLIQUE L3.pdf, p. imprimée(s) 49 (compteur PDF : une page de plus), complétude des rapports.

Question 37 — La rétro-information correspond au retour des informations produites vers les niveaux inférieurs.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : L'information analysée est restituée aux niveaux producteurs des données, notamment les structures périphériques et intermédiaires.

Source : SANTE PUBLIQUE L3.pdf, p. imprimée(s) 47 et 53 (compteur PDF : une page de plus), rétro-information.

Question 38 — Une catastrophe est un événement dont les effets dépassent les capacités de réaction de la communauté.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La catastrophe dépasse les capacités de réaction de la collectivité touchée, contrairement à une urgence qu’elle peut gérer avec ses moyens.

Source : SANTE PUBLIQUE L3.pdf, p. imprimée(s) 59 (compteur PDF : une page de plus), catastrophe et situation d’urgence.

Question 39 — Le risque est indépendant du danger et de la vulnérabilité.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Le risque dépend notamment du danger et de la vulnérabilité. Reformulation : le risque est la probabilité de pertes liées à un événement défavorable compte tenu du danger et de la vulnérabilité.

Source : SANTE PUBLIQUE L3.pdf, p. imprimée(s) 59 (compteur PDF : une page de plus), définition du risque.

Question 40 — Les tremblements de terre sont des catastrophes naturelles.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai dans la classification du cours

Explication : Les tremblements de terre figurent parmi les événements naturels susceptibles de provoquer une catastrophe, avec les cyclones et les tsunamis. Leur impact dépend de l’exposition et de la vulnérabilité.

Source : SANTE PUBLIQUE L3.pdf, p. imprimée(s) 60 (compteur PDF : une page de plus), types de catastrophes naturelles.

Question 41 — L'un des rôles de l'infirmier en cas de catastrophe est de donner l'alerte.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : L’infirmier ou la sage-femme doit alerter rapidement le directeur départemental de la santé afin de faciliter l’organisation des secours.

Source : SANTE PUBLIQUE L3.pdf, p. imprimée(s) 61 (compteur PDF : une page de plus), rôle en cas de catastrophe.

Question 42 — La supervision vise l'amélioration des compétences et du rendement du personnel.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La supervision formative vise l’amélioration des compétences, de la performance et de la qualité des prestations.

Source : SANTE PUBLIQUE L3.pdf, p. imprimée(s) 62–63 (compteur PDF : une page de plus), définition et buts de la supervision.

Question 43 — La supervision est généralement une activité annoncée et périodique.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Le tableau du cours décrit la supervision comme annoncée et périodique, tout en l’inscrivant dans une démarche continue d’accompagnement.

Source : SANTE PUBLIQUE L3.pdf, p. imprimée(s) 63 (compteur PDF : une page de plus), supervision et autres fonctions de gestion.

Question 44 — Le COGES est composé exclusivement d'agents de santé.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Le COGES réunit des représentants communautaires aux côtés du personnel de santé. Reformulation : le COGES n’est pas exclusivement composé d’agents de santé.

Source : SANTE PUBLIQUE L3.pdf, p. imprimée(s) 37–38 (compteur PDF : une page de plus), définition et composition du COGES.

Question 45 — Le comité de gestion participe à la gestion et au fonctionnement des formations sanitaires rurales.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La communauté participe, avec les agents de santé, aux activités de gestion et au fonctionnement des formations sanitaires rurales.

Source : SANTE PUBLIQUE L3.pdf, p. imprimée(s) 37 (compteur PDF : une page de plus), définition du COGES.

Question 46 — Le décret N°93-218 du 03 février 1993 fixe les règles de gestion des formations sanitaires rurales.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai dans le texte de référence du cours

Explication : Le cours cite le décret n° 93-218 du 3 février 1993 comme texte fixant les règles de gestion des formations sanitaires rurales. Cette réponse porte sur le texte cité dans le programme.

Source : SANTE PUBLIQUE L3.pdf, p. imprimée(s) 38 et 42 (compteur PDF : une page de plus), référence réglementaire de la gestion des formations sanitaires rurales.

Question 47 — Le COGES comprend entre 10 et 20 membres.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai selon le cours

Explication : Le cours retient un comité de 10 à 20 personnes représentant les communautés de l’aire sanitaire, avec participation du personnel de santé.

Source : SANTE PUBLIQUE L3.pdf, p. imprimée(s) 38 (compteur PDF : une page de plus), composition du COGES.

Question 48 — Les membres du COGES sont nommés pour un mandat de cinq ans non renouvelables.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Le mandat indiqué dans le cours est de trois ans renouvelables. Reformulation : les membres sont désignés pour trois ans, renouvelables.

Source : SANTE PUBLIQUE L3.pdf, p. imprimée(s) 38 (compteur PDF : une page de plus), durée du mandat.

Question 49 — Les ASC et les AT font partie d'office du COGES.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai selon le cours

Explication : Les agents de santé communautaires et les accoucheuses traditionnelles font partie d’office du comité en raison de leur rôle de relais communautaires.

Source : SANTE PUBLIQUE L3.pdf, p. imprimée(s) 38 (compteur PDF : une page de plus), composition du COGES, nota bene.

Question 50 — La participation aux activités du COGES est rémunérée.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : La participation communautaire aux activités du COGES relève du bénévolat. Reformulation : elle n’est pas une activité rémunérée de manière systématique.

Source : SANTE PUBLIQUE L3.pdf, p. imprimée(s) 38 (compteur PDF : une page de plus), participation bénévole au COGES.

Question 51 — Un membre communautaire du COGES doit résider dans un village desservi par le centre de santé.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai pour les membres communautaires

Explication : Les critères d’appartenance comprennent la résidence permanente dans un village desservi par le centre, la bonne moralité et une activité génératrice de revenu.

Source : SANTE PUBLIQUE L3.pdf, p. imprimée(s) 38 (compteur PDF : une page de plus), critères d’appartenance au COGES.

Question 52 — Le COGES élabore le budget semestriel du centre de santé.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Le COGES élabore le budget semestriel et participe au suivi des dépenses et des mouvements bancaires.

Source : SANTE PUBLIQUE L3.pdf, p. imprimée(s) 39 (compteur PDF : une page de plus), rôles dans la gestion financière.

Question 53 — Le COGES ne joue aucun rôle dans la gestion des ressources humaines.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Le COGES veille notamment à la présence du personnel, à la qualité de la communication et au savoir-être. Ce rôle ne lui confère pas les pouvoirs statutaires de l’administration. Reformulation : le COGES participe à certains aspects du suivi des ressources humaines.

Source : SANTE PUBLIQUE L3.pdf, p. imprimée(s) 39 (compteur PDF : une page de plus), rôles dans la gestion des ressources humaines.

Question 54 — Le COGES veille à la disponibilité des médicaments essentiels et des vaccins.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Le COGES veille à la disponibilité des médicaments essentiels et des vaccins ainsi qu’à la bonne gestion du matériel et des locaux.

Source : SANTE PUBLIQUE L3.pdf, p. imprimée(s) 39 (compteur PDF : une page de plus), gestion du matériel, des médicaments et du local.

Question 55 — Le COGES peut promouvoir l'acceptabilité des services offerts à la population.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : En dehors du centre, le comité fait connaître les activités et favorise leur acceptabilité auprès des populations.

Source : SANTE PUBLIQUE L3.pdf, p. imprimée(s) 40 (compteur PDF : une page de plus), rôles du COGES en dehors du centre.

Question 56 — Le responsable de la gestion financière tient le livret de caisse.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Le livret de caisse permet au responsable financier de noter les recettes et les dépenses du centre.

Source : SANTE PUBLIQUE L3.pdf, p. imprimée(s) 40–41 (compteur PDF : une page de plus), outils et fonctions du responsable financier.

Question 57 — Le président du COGES coordonne les activités du comité.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Le président coordonne les activités, convoque les réunions en accord avec le responsable administratif et participe au contrôle financier.

Source : SANTE PUBLIQUE L3.pdf, p. imprimée(s) 40–41 (compteur PDF : une page de plus), fonctions du président.

Question 58 — Les dons et legs constituent une source de revenus du COGES.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Les dons et legs figurent parmi les sources de revenus, aux côtés des recettes des actes de santé et de la vente de certains documents.

Source : SANTE PUBLIQUE L3.pdf, p. imprimée(s) 42 (compteur PDF : une page de plus), sources de revenus du COGES.